Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
1ª Vara Cível do Foro Regional do Alto Petrópolis da Comarca de Porto Alegre

Av. Protásio Alves, 8144, 7º andar - Bairro: Protásio Alves - CEP: 91260000 - Fone: (51) 3259-4428 - Balcão virtual: 51 99508 5709 - Email: frpoaregapvciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5006535-06.2023.8.21.2001/RS

AUTOR: JOAO CARLOS DENIZ FROES
ADVOGADO(A): RENATA DA VEIGA LIMA BERNARDES
ADVOGADO(A): RODRIGO DA VEIGA LIMA
ADVOGADO(A): DIEGO DA VEIGA LIMA

RÉU: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

SENTENÇA

Vistos os autos.

JOAO CARLOS DENIZ FROES ajuizou a presente ação inicialmente contra **UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA.** relatando ser beneficiário de plano de saúde junto à ré, de n. 00370000018795075, no plano MAX EMPRESARIAL HOSPITALAR, e que é portador de Hepatocarcinoma avançado, CID C22.0, diagnosticado em dezembro de 2019. Narrou que em razão da gravidade atual de seu quadro clínico lhe foi prescrito o uso do inibidor de anti-PDL-!, Atezolizumabe, que é um tipo de imunoterapia em combinação com bevacizumabe, um agente anti-angiogênico, que lhe foi negado na esfera administrativa. Discorreu sobre o seu direito. Requereu a concessão de tutela de urgência e a procedência com a condenação da ré ao fornecimento da medicação indicada. Ainda, pugnou pelo benefício da AJG. Juntou documentos.

Foi concedida a AJG e indeferido o pedido de tutela (evento 3). O autor interpôs recurso, que foi provido.

Citada, a ré contestou (evento 22) aduzindo não ter a obrigação de fornecer o fármaco postulado, em razão do cunho experimental do tratamento, sobre o que discorreu. Postulou a improcedência. Trouxe documentos.

Houve réplica (evento 27).

Oportunizada a dilação probatória (evento 32), o autor postulou a realização de prova pericial (evento 46), que restou indeferido (evento 49). O requerente interpôs recurso, que não foi conhecido. O réu, por sua vez, nada requereu.

Houve determinação da alteração do polo passivo (evento 57).

É o relatório. Decido.

Pretende a parte autora o fornecimento do medicamento Atezolizumabe, que lhe foi negado na esfera administrativa, sob a justificativa de se tratar de terapia experimental.

Há que se definir se deve ou não ser acolhida a justificativa para a recusa de cobertura do tratamento.

Os serviços prestados pelas seguradoras ou planos de saúde estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Tal entendimento, aliás, restou pacificado pelo Egrégio STJ com a edição da Súmula 469:

"*Súmula 469. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.*"

Impende lembrar, dessa forma, o disposto no art. 47 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe a interpretação das cláusulas contratuais sempre de maneira mais favorável ao consumidor:

"*Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.*"

No caso em tela, o laudo juntado com a inicial comprova que a parte autora apresenta diagnóstico de hepatocarcinoma avançado (CID C22.0) e que a solicitação apresentada pelo requerente demonstra a necessidade do fármaco pleiteado para melhora a sua qualidade de vida e controle da doença (evento 1, LAUDO6).

Está, portanto, diretamente relaciona à enfermidade da autora.

Assim, é descabida a negativa administrativa ao argumento de que consiste em uso *off-label*, pois cabe ao médico que acompanha o seu paciente indicar o medicamento compatível com o tratamento de sua patologia e não ao plano de saúde.

Nesse sentido, aliás, seguiu a decisão proferida em grau recursal (AI nº 5184503-61.2023.8.21.7000) ao conceder a tutela inicialmente negada, que ora transcrevo:

> *"O recurso é cabível, tempestivo e está dispensado do preparo, porquanto a parte litiga ao amparo da gratuidade da justiça, enquadrando-se na hipótese prevista no do art. 1.015, I, do CPC, pelo que passo ao seu enfrentamento.*

De início, observo que os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ[1]. Assim, incide, na espécie, o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

Não há discussão acerca da contratação do plano de saúde, do diagnóstico de hepatocarcinoma avançado (CID C22.0) e da indicação médica de tratamento com o medicamento bevacizumabe associado à imunoterapia.

A controvérsia recursal diz respeito ao preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela antecipada de urgência (art. 300 do CPC), no sentido do fornecimento do tratamento médico de que necessita a parte autora.

Pois bem. Ainda que inaplicável a Lei nº 9.656/98, por se tratar de contrato firmado em data anterior a sua vigência, entendo que descabe a negativa de cobertura das despesas concernentes ao custeio do tratamento recomendado pelo médico assistente, pois a escolha deste ocorreu em razão da adequação ao quadro clínico do paciente.

Conforme devidamente justificado no laudo médico (evento 1, LAUDO6):

Laudo Médico

O senhor Joao Carlos Deniz Froes apresenta diagnóstico de hepatocarcinoma avançado (CID: C22.0). O diagnóstico foi feito recentemente e o paciente apresenta nódulos no fígado e metástases em glândula suprarenal esquerda, configurando um tumor bem agressivo. Nesta situação clínica está indicado o uso de bevacizumabe associado à imunoterapia.

Nesta situação clínica, foi aprovado em agosto de 2020, pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) o uso do inibidor de anti-PDL-1, atezolizumabe, que é um tipo imunoterapia em combinação com o bevacizumabe, um agente anti-angiogênico.

O medicamento padrão nesta situação era o sorafenibe há mais de 10 anos. Este remédio tinha demostrado em um estudo clínico internacional aumentar a sobrevida global nesta situação clínica, de forma bem significante.

A utilização da combinação de atezolizumabe com bevacizumabe na primeira linha se baseia no estudo de fase III IMbrave-150, que randomizou 501 pacientes com hepatocarcinoma metastático para atezolizumabe, 1200mg EV, a cada 3 semanas mais bevacizumabe 15mg/kg EV, a cada 3 semanas versus sorafenibe. 400mg, 2x ao dia (N Engl J Med 382:1894, 2020).

Após seguimento mediano de 8,6 meses, a sobrevida global mediana foi de 19,2 meses no braço da combinação e de 13,4 meses para sorafenibe (p=0,0009). A sobrevida livre de progressão também favoreceu o braço da combinação (6,8 versus 4,3 meses; p<0,0001). A taxa de resposta foi mais que duas vezes superior na combinação, por critérios internacionais (33% versus 13%; p<0,00001), além de uma taxa de resposta completa em torno de 5%.

A análise pré-especificada de dados relatados por pacientes mostrou benefícios clinicamente significativos em qualidade de vida e controle de sintomas da doença a favor da combinação atezolizumabe e bevacizumabe em comparação a sorafenibe, fortalecendo o risco-beneficio positivo da terapia combinada na primeira linha do hepatocarcinoma (Lancet Oncol 22-99, 2021).

Assim, sendo, a combinação atezolizumabe e bevacizumabe é o novo padrão mundial para esta situação clínica. Devido a gravidade do quadro, o início deste tratamento é claramente urgente, e atrasos certamente terão repercussões negativas.

O tratamento deve ser usado por 6 meses, pelo menos. A dose do atezolizuamabe é 1200mg, EV, a cada 3 semanas, e o bevacizumabe é de 15mg/kg, o que resulta, em 900mg, a cada 3 semanas.

Atenciosamente,

Dr. Jeferson Vinholes
Oncologista
CRM: 188.182.000-53

Dr. Jeferson Vinholes

Portanto, considerando a indicação médica, necessária se mostra a cobertura, pois se está a tratar de um bem de hierarquia superior que é a saúde humana.

Outrossim, é de ser ressaltado que o contrato de seguro não dispensa a boa-fé entre as partes contratantes, como estatuído nos artigos 422 e 765 do Código Civil:

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

[...]

Art. 765. O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes.

E, nessa linha, o Código de Defesa do Consumidor, que em seu artigo 51 e incisos, inquina de nulas as cláusulas abusivamente redigidas, especificamente os incisos IV e XI, que é do que aqui se trata:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

[...]

IV – estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;

[...]

XV – estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor;

Ademais, o que importa é a existência de cobertura do contrato para a doença apresentada pela parte autora, não importando a forma como o tratamento será ministrado ou mesmo a utilização off label.

A esse respeito, a jurisprudência do eg. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. HEMODIÁLISE E OXIGENOTERAPIA. ABUSO. DANOS MORAIS. DIMINUIÇÃO. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 2. O Tribunal de origem, com base em normas do CDC, considerou indevida a negativa de cobertura para tratamento de hemodiálise e oxigenoterapia, porque "a seguradora sequer menciona suposta cláusula contratual de exclusão dos tratamentos solicitados", e porque eventual cláusula seria "nula de pleno direito, uma vez que acaba por restringir direito inerente à natureza do contrato, qual seja, preservação da vida do segurado, o que fere o princípio da vulnerabilidade contido no Código de Defesa do Consumidor" (e-STJ fls. 278/279). 3. Rever a conclusão da Corte de origem quanto à existência de dano moral decorrente da gravidade do fato, bem como em relação à alegada licitude da negativa de cobertura, exigiria o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como nova interpretação dos termos pactuados, o que esbarra nas Súmulas n. 5 e 7 o STJ. ***4. "Esta Corte Superior possui pacífica jurisprudência, no sentido de que, mesmo em se tratando de planos e seguros privados de assistência à saúde celebrados antes da vigência da Lei 9.656/98 (e não adaptados ao novel regime), as controvérsias jurídicas instauradas entre operadoras e usuários são solucionadas à luz do Código de Defesa do Consumidor, o qual alcança, inclusive, contratos que lhe sejam anteriores, por refletirem obrigações de trato sucessivo" (REsp 2.005.439/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, decisão publicada em 1º/7/2022). 5. "O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Desse modo, entende-se ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário" (AgInt no AREsp n. 1.577.124/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/4/2020, DJe de 4/5/2020).*** *6. "A indenização por danos morais fixada em quantum sintonizado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não enseja a possibilidade de interposição do recurso especial, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática, cabendo sua revisão apenas em casos de manifesta excessividade ou irrisoriedade do valor arbitrado, o que não se evidencia no presente caso. Incidência da Súmula 7 do STJ" (AgInt no AREsp 1.722.400/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020). 7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.963.072/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.) [grifei]*

Ainda, ao menos até o presente momento, não há demonstração da oferta de migração para plano regulamentado.

Assim, tendo em vista as peculiaridades do caso, entendo que o tratamento indicado pelo médico especialista que acompanha a parte autora é o mais indicado para suprir suas necessidades, sob pena de ocorrência de graves e irreversíveis danos à saúde do paciente caso o tratamento não seja custeado, restando, pois, evidenciada, a probabilidade do direito.

Já o risco de dano se depreende da própria recomendação médica, expressa no sentido da urgência.

Nesse sentido, precedente desta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. PLANO DE SAÚDE NÃO REGULAMENTADO. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE CÂNCER DE PRÓSTATA. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE EXCLUA O DEVER DE COBERTURA DE MEDICAMENTOS. VERIFICADA A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. 1) Tratando-se de plano não regulamentado, vez que firmado anteriormente à vigência da Lei nº 9.656/1998, se aplicam apenas as disposições nele pactuadas e as normas do CDC, conforme o verbete nº 608 da súmula de jurisprudência: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". 2) O artigo 35 da Lei nº 9.656/98 prevê que suas disposições serão aplicáveis apenas a contratos celebrados a partir de sua vigência, não atingindo, assim, o fato jurídico posto em exame. 3) Muito embora os artigos 10, parágrafo 2°, e 35-E da Lei n° 9.656/1998, assim como o artigo 2° da Medida Provisória n° 2.177-44/2001, apresentassem disposição prevendo a incidência das novas regras relativas aos planos de saúde em contratos celebrados anteriormente à vigência do diploma normativo em questão, por afronta ao disposto no artigo 5°, inciso XXXVI, da Constituição da República, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na ADI 1931, declarou a inconstitucionalidade de suas disposições, por afronta à segurança jurídica. 4) Caso dos autos em que inexiste o contrato firmado, ao contrário do alegado pela parte ré, cláusula contratual relativa à exclusão de medicamentos, o que, inclusive, justifica a liberação, na via administrativa, do outro fármaco postulado pelo autor, que igualmente foi prescrito pelo seu médico assistente em decorrência do diagnóstico de câncer de próstata e sua administração é via oral e domiciliar. 5) Seguindo essas premissas, e considerando que, no caso dos autos, restou demonstrada a probabilidade do direito da parte e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a decisão de origem, que deferiu o pedido de tutela de urgência, merece ser mantida. 6) Ausente necessidade de fixação de caução, mormente porque não há perigo de reversão da medida, além de constituir óbice à satisfação do próprio direito perseguido. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.(Agravo de Instrumento, Nº 50840595420228217000, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 28-07-2022)

Desse modo, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é caso de reforma da decisão agravada, para determinar que o plano de saúde forneça o medicamento bevacizumabe associado à imunoterapia, conforme laudo médico.

Ante o exposto, voto por prover o agravo de instrumento."

Portanto, é inviável a negativa da ré de fornecer o medicamento sob a alegação de que o tratamento é *off label*.

Diante do exposto, julgo **PROCEDENTE** o pedido para tornar definitivos os efeitos da decisão antecipatória.

Condeno a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que vão fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, recolhidas eventuais custas ainda pendentes de pagamento e nada mais sendo requerido, baixe-se.

Documento assinado eletronicamente por **CRISTINA NOSARI GARCIA, Juíza de Direito**, em 23/09/2025, às 15:03:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10091138261v6** e o código CRC **ed80410c**.

---

1. Súmula 608 do STJ. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. ↩